Procedimiento de derrames biológicos químicos y textiles

Objetivo

Establecer una secuencia verificable para procedimiento de derrames biológicos químicos y textiles, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

Alcance y responsabilidades

Aplicación en odontologia ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

Derrame biológico

Delimitar, retirar personas, evaluar salpicaduras y usar EPP. Recoger cortopunzantes con pinza apropiada sin manos; absorber y retirar materia orgánica, limpiar y desinfectar con producto y tiempo indicados. Gestionar residuos, retirar EPP e higienizar manos.

Derrame químico

Identificar sustancia por ficha de seguridad; aislar y actuar solo con entrenamiento y kit compatible. No neutralizar improvisando mezclas ni limpiar mercurio con aspiradora. Solicitar apoyo especializado si cantidad/riesgo supera capacidad.

Textiles

Transportar ropa contaminada cerrada sin sacudir, separada de material limpio; procesamiento por proveedor/procedimiento compatible. No lavar paños clínicos con ropa personal. Cambiar cuando sucio y no usar paño de baño para superficies clínicas.

Cierre

Documentar exposición, cantidad, producto, limpieza, disposición y condición de reapertura; activar atención ocupacional si contacto con piel lesionada, mucosas o punción.

Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones

Preparación y selección

Identificar superficie/dispositivo, material, suciedad y nivel de riesgo. Leer etiqueta, ficha técnica y de seguridad; verificar uso autorizado, compatibilidad, concentración, vida útil y tiempo de contacto. Definir EPP, ventilación y elementos diferenciados por zona antes de iniciar.

Ejecución verificable

Delimitar área, retirar suciedad y residuos, limpiar y aplicar desinfectante compatible. Mantener contacto indicado, sin secado anticipado ni mezclas improvisadas. Para agua, succión, impresiones o residuos aplicar instrucciones particulares descritas en este documento; limpiar no equivale a esterilizar.

Contención de fallas

Ante producto no identificado, dilución incorrecta, derrame o superficie incompatible, detener y aislar área/material. Evaluar exposición y atención ocupacional cuando pertinente. Repetir proceso solo después de corregir causa y comprobar que material no quedó dañado o con residuo peligroso.

Cierre de actividad

Registrar área/equipo, producto/lote, preparación, tiempo real, resultado y responsable; liberar espacio cuando condición segura esté verificada. Los controles de agua requieren resultados y acciones, los residuos requieren entrega y soporte; no sustituirlos por una lista diaria genérica.

Supervisión y mejora

Observar técnica y oportunidad entre pacientes, disponibilidad de EPP/productos y correspondencia con cronograma. Revisar desviaciones recurrentes, calidad del agua, contaminación ambiental y capacidad de personal; ajustar frecuencia por riesgo y conservar evidencia de capacitación.

Frecuencia y puntos de control

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

Registros relacionados

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-LD10 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

Verificación, fundamento y adopción

Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas × 100. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Residuos

Resolución 591 de 2024, manual de gestión de residuos generados en atención en salud; Decreto 780 de 2016. Diagnóstico, ruta y soportes reales por sede.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%20591%20de%202024.pdf

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609

Reprocesamiento

Resolución 2183 de 2004 y criterios vigentes de habilitación; Resolución 914 de 2025 y manual DMER: vigencia general prevista 03/01/2027 conforme al artículo 15. Revisar transitoriedad del artículo 12 y reglas específicas del tipo de prestador.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_0914_2025.htm

Fuentes técnicas particulares

Consultar versión íntegra y vigente, población y metodología; adaptar con trazabilidad. Una referencia técnica orienta práctica y no es legislación colombiana.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2183-de-2004.pdf ;
https://www.cdc.gov/dental-infection-control/hcp/summary/sterilization-disinfection.html

Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.